

Dolor abdominal recurrente o crónico

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2016 Módulo 3

La prevalencia exacta es desconocida, se estima que la padecen entre el 10 y 20% de los niños y adolescentes entre los 4 y 18 años.

Presenta dos picos de frecuencia:

El primero entre los 5 y 7 años, con igualdad entre ambos sexos.

El segundo ocurre entre los 8 y 12 años, con una frecuencia mayor y claro predominio en las niñas.

En la mayoría de los niños la causa es funcional y en menos del 10% se encuentra una causa orgánica, esta debe siempre considerarse en primer lugar en niños menores de 4 años.

Los síntomas y signos de alarma son:

- Localización del dolor lejos de la zona periumbilical o irradiación a miembros o espalda.
- Dolor persistente en los cuadrantes superior o inferior derechos.
- Cambio en las características o frecuencia de las deposiciones.
- Presencia de sangre en las deposiciones.
- Estado nauseoso y vómitos persistentes o biliosos.
- Disfagia.
- Artritis o artralgias.
- Diarrea nocturna.
- Dolor nocturno que despierta al niño.
- Fiebre inexplicable.
- Pérdida de peso o detención del crecimiento en talla.
- Disuria.
- Enfermedad perianal: fisuras, fístulas, abscesos, etc.
- Hepatomegalia y/o esplenomegalia.
- Distensión o efecto de masa localizados.
- Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, celíaca o úlcera péptica

Ante la sospecha de organicidad se podrán realizar pruebas complementarias y/o derivar al gastroenterólogo infantil

Estudios de laboratorio

Inicial: hemograma, VSG, PCR, GOT, GPT, GGT, FAL, amilasemia, urea, creatinina, orina, coprocultivo, parasitológico, sangre oculta en materia fecal. Búsqueda de guardias en fresco.

En un segundo o tercer nivel, y según sospecha clínica se puede solicitar, serología para enfermedad celíaca, test de hidrógeno espirado para intolerancia a lactosa, C13, urea en aire espirado para determinación de *Helicobacter pylori*, anticuerpos para enfermedad inflamatoria intestinal.

Estudios de imágenes

- Radiografía simple de abdomen: no está justificada la realización, siendo su indicación excepcional.
- Tránsito intestinal y colon por enema: sospecha específica de causa orgánica.
- Ecografía abdominal: practicada en pacientes sin síntomas o signos de alarma, tiene una frecuencia de hallazgos menor al 1%, y estos no suelen tener relación causal con el dolor abdominal. Con síntomas como ictericia, molestias urinarias, dolor en flancos, la ecografía puede detectar anomalías hasta en el 10% de los pacientes.
- Tomografía Computada: sospecha clínica específica de causa orgánica.

Otros estudios

- Endoscopia digestiva alta y baja para patologías específicas y toma de biopsias.
- pHmetría, impedanciometría y manometría para estudio de RGE y constipación.

Dolor abdominal crónico funcional - Criterios de Roma IV:

“Al menos dos meses de dolor abdominal continuo o intermitente, que interfiere con la actividad normal, sin relación o relación muy ocasional de eventos fisiológicos.

Fisiopatología

Los niños con DACF tendrían **disminuido el umbral doloroso visceral** y responderían frente a estímulos convencionales de manera exacerbada (hiperalgesia) y así, el gas generado en la digestión alimentaria, o el efecto presor del bolo, o cambios sutiles en su composición, que habitualmente no son estímulos dolorosos, actuarían como desencadenantes.

Además la **dismotilidad gastrointestinal y colónica**, ha sido demostrada alteraciones de la motilidad que podrían ser el resultado de una disautonomía vegetativa y más específicamente de su actividad simpática en el tracto gastrointestinal, originando dolores (calambres) por peristaltismo anómalo exacerbado.

Tratamiento

- Dieta: aporte adecuado de fibra en la dieta, evitar el consumo excesivo de lácteos, almidones, bebidas carbonatadas y con cafeína, sorbitol (chicles, caramelos).

Una dieta hipograsa puede mejorar aquellos pacientes con náuseas y distensión abdominal superior. No hay evidencia del beneficio de la dieta sin lactosa.

- La utilización de ranitidina u omeprazol por 4 semanas, puede ser útil en paciente con síntomas dispépticos.
- El uso de proquinéticos (domperidona) son controvertidos.
- IC a Psicología ante la detección de estrés y ansiedad.
- Algunos estudios sugieren que amitriptilina a dosis baja (0,2-0,4 mg/kg por día), al acostarse, o ciproheptadina pueden ser usados en casos de difícil manejo.

El DAC funcional incluye las siguientes entidades:

- Dispepsia funcional.
- Síndrome de intestino irritable.
- Migraña abdominal.
- Dolor abdominal funcional (No especificado de otro modo).

Dispepsia funcional

Debe incluir **uno o más de los siguientes**, al menos cuatro días por mes, al menos dos meses antes del diagnóstico.

- Plenitud postprandial.
- Saciedad temprana.
- Dolor o ardor epigástrico, no relacionado con la defecación (puede ser inducido o aliviarse por la ingestión de alimentos).
- Después de una evaluación apropiada los síntomas no pueden ser explicados por otra condición médica.

Subtipos:

1. Síndrome de distrés postprandial: incluye distensión postprandial, saciedad precoz que evita terminar una comida regular. Soportan el diagnóstico la distensión del abdomen superior, náuseas postprandiales o eructos excesivos.

2. Síndrome de dolor epigástrico, el cual incluye todos los siguientes: dolor o acidez localizados en epigastrio. El dolor no es generalizado ni localizado en otras regiones del abdomen o el tórax y no se alivia con la defecación o eliminación de gases.

La esofagogastroduodenoscopia estaría indicada en niños con Síndrome de Dispepsia con una historia familiar de úlcera péptica, infección por *Helicobacter Pylori*, y en niños de más de 10 años de edad, cuando los síntomas persistan más de 6 meses o si son tan severos que afectan la actividad diaria, incluido el sueño.

Síndrome de intestino irritable

“Dolor tipo cólico, difuso, periódico, que cursa con alteraciones del ritmo intestinal”.

Criterios diagnósticos: debe incluir **todos** los siguientes:

1. Dolor abdominal, al menos 4 días al mes, asociado con una o más de las siguientes:
 - Relacionado a la defecación.
 - Cambio en la frecuencia de las deposiciones.
 - Cambio en la apariencia de las heces.
2. En los niños con constipación el dolor no se resuelve con la resolución de la constipación.
3. Después de una evaluación apropiada, los síntomas no pueden ser explicados por otra condición médica.

Puede ser dividido en:

- Con constipación,
- Con diarrea,
- Con constipación y diarrea,
- Inespecífico.

Tratamiento

Hay datos que soportan la utilidad de los probióticos.

Se sugiere la reducción en la dieta de oligosacáridos fermentables, disacáridos y monosacáridos.

Migraña abdominal

Se caracteriza por intensos episodios paroxístico de dolor abdominal, dos o más veces en los últimos 6 meses y deben incluir **todos los criterios siguientes:**

- Intensos episodios paroxísticos de dolor abdominal intenso, agudo, periumbilical, de la línea media o difuso de una hora o más de duración.
- Intervalos libres de semanas o meses.
- El dolor interfiere con la actividad habitual.
- El dolor se asocia a dos o más de los siguientes: anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia, palidez.
- Después de una apropiada evaluación, el dolor no puede ser explicado por otra condición médica.

Evaluación

Requiere excluir procesos asociados con síntomas episódicos severos, tales como:

- Obstrucción intermitente del intestino delgado o urológica
- Pancreatitis recurrente
- Enfermedad del tracto biliar
- Porfiria
- Desórdenes psiquiátricos.

Tratamiento

Existen estudios que encuentran efectos beneficiosos en profilaxis con drogas tales como pizotifen, amitriptilina, propranolol y ciproheptadina.

Dolor abdominal funcional (no especificado de otro modo)

Criterios diagnósticos: al menos 4 veces por mes, dos meses antes del diagnóstico, y debe incluir **todos los criterios siguientes:**

- Dolor abdominal continuo o episódico que no ocurren solamente durante eventos fisiológicos.
- Criterios insuficientes para encuadrarlos en Síndrome de Intestino Irritable, Dispepsia Funcional o Migraña Abdominal.
- Después de una apropiada evaluación, el dolor no puede ser explicado por otra condición médica.